

PRÉSENTATION CLINICO-BIOLOGIQUE SÉVÈRE D'UNE NÉPHROPATHIE À IGA (MALADIE DE BERGER) CHEZ UN ADOLESCENT : À PROPOS D'UN CAS

G. BOURZOUZOU^{1,2}, Y. HANLAOUI^{1,2}, T. BENCHARIF MADANI^{1,2}

1. Service de Pédiatrie, EHS Sidi Mabrouk, Constantine, Algérie

2. Université Constantine 3, Faculté de Médecine, Algérie

INTRODUCTION

La néphropathie à IgA (maladie de Berger) est la glomérulonephrite primitive la plus fréquente. Chez l'enfant, elle peut évoluer silencieusement vers l'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT).

OBSERVATION

Un adolescent de 13 ans, avec notion d'une hématurie microscopique remontant à 4 ans, est transféré pour une IRCT révélée par une dyspnée. L'examen retrouve une altération de l'état général, une pâleur intense, une hypertension artérielle menaçante (180/130 mmHg) et une respiration de Kussmaul.

RÉSULTATS BIOLOGIQUES ET HISTOLOGIQUES

Urémie (2,59 g/l), créatininémie (162 mg/l), hyperkaliémie (6,3 mmol/l), acidose métabolique (pH 7,15) et anémie profonde (Hb 5,1 g/dl). Le bilan immunologique classique (FAN, ANCA) est négatif et le complément normal, mais le dosage sérique révèle un taux d'IgA totales élevé. La protéinurie est massive (rapport Pr/Cr 3,3 g/g).

La ponction-biopsie rénale objective une glomérulonephrite à dépôts mésangiaux d'IgA (5 glomérules en pain à cacheter sur 11) avec un score d'Oxford: M0, C0, S1, E0, T1. Le patient a nécessité l'hémodialyse, la transfusion et relais par dialyse péritonéale.

DISCUSSION

La maladie de Berger est une pathologie dysimmunitaire médiée par des IgA1 sous-galactosylées. Si la certitude diagnostique reste histologique, l'élévation des IgA sériques totales renforce l'orientation clinique de cette auto-immunité.

Notre observation s'illustre par sa présentation extrêmement tardive, malgré l'existence d'une hématurie microscopique inaugurale datant de 4 ans, avec des lésions chroniques irréversibles à la biopsie (sclérose S1, atrophie tubulaire T1) expliquant l'entrée d'emblée au stade d'IRCT. Ce tableau gravissime souligne les limites d'une clinique souvent muette, rappelant la pertinence diagnostique de la recherche de biomarqueurs précoces (Gd-IgA1) dans la physiopathologie de la maladie.

CONCLUSION

L'exploration anatomo-biologique est cruciale dans la néphropathie à IgA pédiatrique, y compris au stade de séquelles terminales.

Le dépistage précoce des anomalies immunitaires et le suivi d'une hématurie microscopique demeurent un défi majeur pour prévenir cette évolution redoutable.